Psicopatología de la audición y el lenguaje

Unidad 2. Trastornos de la comunicación y el habla: identificación, abordaje y parámetros diferenciadores

ÍNDICE

Contenido

ÍNDICE 1
INTRODUCCIÓN 2
LOS TRASTORNOS DE LA COMUNICACIÓN: TAXONOMÍA DIFERENCIAL 3
Sección 2.1 Introducción 3
Sección 2.2 Trastorno del lenguaje 3
Sección 2.3 Trastorno de los Sonidos del Habla 5
Sección 2.4 Trastorno Social-Pragmático 5
Sección 2.5 Trastorno de la Fluidez de inicio en la infancia (TFI) 7
Sección 2.6 Trastorno de la Comunicación no específicado 8
CLASIFICACIÓN DE LOS TRASTORNOS DEL HABLA 9
Sección 3.1 Introducción 9
Sección 3.2 Trastornos de los Sonidos de Habla 9
Sección 3.3 Disglosia 11
Sección 3.4 Disartria 14
Sección 3.5 Trastornos de la fluidez 14
Sección 3.6 Disfonía 15
RESUMEN DEL TEMA 19
GLOSARIO 20
BIBLIOGRAFÍA 22

INTRODUCCIÓN

Es indiscutible que las habilidades comunicativas desarrolladas en los primeros cinco años de vida y consolidadas en los años escolares posteriores tienen un papel fundamental en el desempeño social, académico y laboral, así como en el bienestar personal/emocional a lo largo de la vida del individuo (Rupérez et al., 2022).

Las patologías de la comunicación y el habla son heterogéneas y engloban a un grupo muy diverso de alteraciones de su desarrollo, genéticas o adquiridas, caracterizadas principalmente por un déficit en la comprensión, producción y uso del lenguaje. La diversidad en la etiología, las manifestaciones clínicas, el pronóstico y el tratamiento, junto a la alta frecuencia (10-15% en menores de 6 años) hace que la atención a los niños que las presentan suponga un reto para el especialista en audición y lenguaje (Artigas-Pallarés et al., 2022).

El habla se define como la producción de sonidos expresivos, y comprende la articulación, la fluencia, la voz y la calidad de resonancia, de que el concepto de lenguaje incluye la forma, la función y el uso cotidiano de símbolos con la intención de comunicarse, tanto de forma verbal como no verbal. Y de forma más global, la comunicación hace referencia a cualquier conducta verbal o no verbal, intencional o no, que influya en el comportamiento, las ideas o las actitudes de otro individuo (Rupérez et al., 2022).

Tomando como referencia lo anterior, esta unidad dos tiene por objetivos: (1) delimitar las principales características que definen cada uno de los trastornos de la comunicación y el habla; (2) analizar de forma exhaustiva y critica dichas alteraciones para poder establecer diferenciaciones entre el habla y la comunicación.

LOS TRASTORNOS DE LA COMUNICACIÓN: TAXONOMÍA DIFERENCIAL

Sección 2.1 Introducción

Desde la publicación del DSM-5 (2013), algunas de las patologías del lenguaje, el habla y la comunicación se incluyen para su catalogación diagnóstica dentro de los trastornos de la comunicación (TC), que se consideran trastornos del neurodesarrollo cuando comienzan a una edad temprana, pueden producir limitaciones significativas en el desarrollo del individuo y no se pueden atribuir a un deterioro auditivo o sensorial, a una disfunción motora o a otra afección médica o neurológica, y no se explican mejor por una discapacidad intelectual (Rupérez et al., 2022).

Incluyen el trastorno del lenguaje (TL), el trastorno de los sonidos del habla o fonológico (TSH), el trastorno de la fluidez de inicio en la infancia (TFI), también llamado tartamudez, el trastorno de la comunicación social o pragmático (TCS) y el trastorno de la comunicación no especificado (Valera, 2017).

La prevalencia de estos trastornos es variable e imprecisa, y depende de los criterios diagnósticos utilizados en los diferentes estudios. Se estima que en menores de 6 años van a presentar TL un 5-7%; TSH, un 3,5-5%, y TFI, un 0,5-1,5% (Artigas-Pallarés et al., 2022). En relación con el género, son más frecuentes en varones, con ratios entre 1,3:1 y 2:1.

Siguiendo a Rupérez et al. (2022), la etiología de los TC es idiopática, y la gran mayoría de estudios coinciden en su alta tasa de heredabilidad (proporción de la variación clínica atribuible a la carga genética, que oscila entre 0 y 1). En el TFI o tartamudeo, el índice de heredabilidad es de 0,7 y es 3-6 veces más frecuente en niños con antecedentes familiares. Por su parte, en el TL se observan unos índices de heredabilidad elevados de 0,5-0,75 y numerosos genes se han implicado en este trastorno y en otros trastornos del neurodesarrollo: trastorno del espectro del autismo (TEA), discapacidad intelectual (DI) o trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH).

Sección 2.2 Trastorno del lenguaje

2.2.1. Conceptualización, etiología y carácter diferencial

El DSM-5 define el Trastorno del Lenguaje (TL) como la presencia de dificultades persistentes en la adquisición y uso del lenguaje. Estas dificultades se deben a déficits en la comprensión o producción de palabras, frases, estructuras o narración. No solo son evidentes en la comunicación hablada, sino también en la escrita o el lenguaje de signos. Los niños con TL suelen tener un vocabulario limitado, una estructura gramatical simplificada o inapropiada para su edad y un discurso alterado, especialmente en la narración.

Es esencial prestar atención tanto a las habilidades expresivas como a las receptivas del individuo para orientar adecuadamente el diagnóstico y las evaluaciones pertinentes. Esto ayuda a descartar posibles alteraciones sensoriales, cognitivas o motoras, y a diferenciar el TL

de otras condiciones como la hipoacusia o el retraso global del desarrollo-discapacidad intelectual.

Antes de los 4 años, las diferencias en el desarrollo del lenguaje son amplias y el pronóstico varía, pero a partir de esa edad, estas diferencias se vuelven más estables y pueden llevar a dificultades persistentes a largo plazo. Por lo tanto, se destaca la importancia de la intervención temprana.

El DSM-5 simplifica la tipología de los trastornos del lenguaje en un solo apartado, eliminando la distinción entre trastorno expresivo y mixto (comprensivo-expresivo). Se clasifica definitivamente como un trastorno del neurodesarrollo, caracterizado por ser evolutivamente variable y claramente disfuncional. Esto abarca cualquier nivel de gravedad y se define por la adquisición del lenguaje (comprensivo o expresivo) por debajo de lo esperado para la edad. No es necesario que el desarrollo del lenguaje sea inferior al desarrollo cognitivo no verbal para el diagnóstico.

Además, el DSM-5 reconoce la posibilidad de comorbilidad del TL con otros trastornos del neurodesarrollo como el Trastorno del Espectro Autista (TEA), el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), el Trastorno Específico del Aprendizaje y el Trastorno del Desarrollo de la Coordinación (TDC). También puede estar asociado a problemas emocionales, conductuales o a factores socioambientales (véase Tabla 1). Aproximadamente el 30% de los casos de TL pueden coexistir con otros trastornos del neurodesarrollo.

Tabla 1.

Trastorno del lenguaje en el DSM-V (Rupérez et al., 2022)

Criterios diagnósticos DSM-5	Diagnóstico diferencial
A. Dificultad persistente en la adquisición y uso del lenguaje en todas sus modalidades (hablado, escrito, lenguaje de signos) **B. Las capacidades del lenguaje están por debajo a lo esperado para la edad** y esta alteración va a causar limitaciones en la comunicación eficaz, lo que interfiere a nivel social, académico o laboral **C. Inicio de síntomas** en las primeras edades del desarrollo **D. Dificultades no atribuibles a** afecciones congénitas o adquiridas	• Variaciones de la normalidad • Hablantes tardíos (<30 meses) • Hipoacusia • Disfunción motora u otra afección médica o neurológica • Retraso global del desarrollo o discapacidad intelectual (si explica las dificultades del lenguaje) • Trastornos neurológicos: afasias adquiridas • Trastornos del lenguaje regresivos **Comorbilidad posible** • Trastorno específico del aprendizaje • Trastorno por déficit de atención e hiperactividad • Trastorno del espectro autista • Trastorno del desarrollo de la coordinación • Trastorno de la comunicación social (pragmático)

2.2.2. Operatividad del término

Existen controversias respecto a la terminología y se convive en la actualidad con diferentes nomenclaturas: trastorno del lenguaje (TL) del DSM-5 frente a trastorno específico del lenguaje (TEL), el más usado en España hasta ahora, y trastorno del desarrollo del lenguaje (TDL) como término más recomendado por los expertos en la actualidad para referirse a los mismos cuadros. Se elimina el término “específico”, ya que las investigaciones recientes sugieren que el trastorno no se limita al dominio del lenguaje.

Sección 2.3 Trastorno de los Sonidos del Habla

El DSM-5 define el trastorno de los Sonidos del Habla como una "dificultad persistente en la producción fonológica que afecta la comprensión del habla o la comunicación verbal de mensajes".
Para diagnosticar el trastorno fonológico, se deben cumplir ciertos criterios diferenciales (Tabla 2). Los niños que experimentan problemas de pronunciación en las etapas tempranas tienen un mayor riesgo de enfrentar dificultades en la lectoescritura en el futuro, además de problemas en sus relaciones sociales y una baja autoestima.

Tabla 2.

Trastorno de los Sonidos del Habla en el DSM-V (Rupérez et al., 2022)

Criterios diagnósticos DSM-5	Diagnóstico diferencial
A. Dificultad persistente en la producción fonológica que interfiere con la inteligibilidad del habla o impide la comunicación verbal de mensajes B. La alteración causa limitaciones en la comunicación eficaz que interfieren a nivel social/académico o laboral C. Inicio de síntomas en primeras edades de desarrollo D. Dificultades no atribuibles a afecciones congénitas o adquiridas	• Variaciones normales del habla (regionales, sociales y culturales) • Hipoacusia u otra deficiencia sensorial • Deficiencias estructurales • Disartria (alteraciones del habla justificadas por un trastorno motor) • Mutismo selectivo (trastorno de ansiedad con ausencia de habla en uno o más contextos)

No obstante, no todos los problemas de pronunciación conllevan estos riesgos. Por lo tanto, es crucial identificar con precisión el tipo de dificultades fonético-fonológicas que un niño experimenta mediante una evaluación especializada que señale los errores específicos en el habla y si estos están acordes con su nivel de desarrollo y edad.
El desarrollo fonético-fonológico es un proceso gradual, pero es esencial comprender lo que se espera de un niño a partir de los 3 años para un diagnóstico temprano. También es fundamental distinguir entre errores fonéticos y dislalias (incapacidad para pronunciar un sonido que debería estar presente a su edad) y errores fonológicos (persistencia de simplificaciones del habla más allá de lo esperado en su desarrollo normal), ya que el enfoque de intervención varía según el tipo de error.
En ambos casos, es esencial considerar el grado de comprensión del habla y si se ajusta o no al desarrollo típico (la comprensión del habla para desconocidos es del 25% a los 18 meses, el 50% a los 2 años, el 75% a los 3 años y el 100% a los 4 años).

Sección 2.4 Trastorno Social-Pragmático

El trastorno de comunicación social (TCS) se describe por primera vez en el DSM-5 y se define por “la presencia de dificultades persistentes en el uso social de la comunicación verbal y no verbal, en ausencia de intereses y comportamientos restringidos y repetitivos, que no pueden atribuirse a otra afección médica o neurológica ni a la baja capacidad en los dominios de

morfología y gramática, y no se explican mejor por TEA, discapacidad intelectual-retraso global del desarrollo u otro trastorno mental".

Se caracteriza por dificultades en:

- El uso de la comunicación para propósitos sociales, como saludar y compartir información, de manera apropiada al contexto social.
- La habilidad para captar e integrar las claves contextuales (ambientales, sociales y personales, incluyendo conocimiento y experiencias) en la interpretación de significados.
- La capacidad para adecuar la comunicación al contexto social; la comprensión de las intenciones de los interlocutores y de las convenciones sociales.
- Las habilidades pragmático-conversacionales (seguir las reglas conversacionales y ser capaz de mantener conversaciones de ida y vuelta, manteniendo el tema y produciendo contenidos o estilos de conversación adecuados al interlocutor y al contexto, etc.).
- La comprensión del lenguaje implícito o ambiguo, como por ejemplo bromas, modismos o metáforas, e integrar comunicación no verbal y verbal.

A menudo se menciona también habla excesiva (hiperverbales), déficits en la comprensión del discurso narrativo y conversacional y problemas de recuperación léxica. Es frecuente que aparezca un retraso inicial del primer lenguaje, con buena evolución en aspectos formales que contrastan con las anomalías en el uso social del lenguaje. En los inicios del lenguaje es frecuente la coexistencia de la ecolalia y la jerga.

Además, el TCS puede coexistir con otros trastornos de la comunicación, pero no se puede diagnosticar en presencia de un TEA. Los niños con TEA presentan dificultades persistentes de comunicación social pero también déficits en reciprocidad socioemocional y comprensión social, así como patrones repetitivos y restringidos de conductas, actividades e intereses.

Sin embargo, como ya se ha comentado, a menudo el diagnóstico diferencial es complicado, fundamentalmente antes de los 5-6 años. Con anterioridad a la inclusión del TCS en el DSM-5, la mayor parte de los casos eran diagnosticados como TEA, aunque algunos se diagnosticaban dentro de los TEL, siguiendo la clasificación diagnóstica de Rapin y Allen (1983, 1987), dentro del término de déficit semántico-pragmático.

De este modo, el TCS es una entidad poco conocida, recientemente incorporada y que resulta ser la menos precisa de todos los trastornos de la comunicación, debido a que sus manifestaciones no se observan dentro de dimensiones objetivables y medibles, como la semántica o la fonología, sino que se evidencian dentro de la heterogeneidad y amplitud que se

delimitan en la interacción social, implicando a las habilidades sociales y a la adaptación de la conducta.

Así pues, en definitiva, la problemática con el TCS es que se presenta en forma primaria o como sintomatología de otros trastornos como el TEL, TDAH, TEA, entre otros, lo que genera confusión al momento de la evaluación diagnóstica.

Sección 2.5 Trastorno de la Fluidez de inicio en la infancia (TFI)

El trastorno de la fluidez del habla de inicio en la infancia, también conocido coloquialmente como "tartamudeo" (anteriormente disfemia), está definido en el DSM-5 como "alteraciones en la fluidez y en la organización temporal del habla, que son inadecuadas para la edad y las habilidades de lenguaje del individuo. Estas alteraciones persisten en el tiempo y se caracterizan por la aparición de uno o más de los siguientes factores: repetición de sonidos, sílabas o palabras monosílabas, prolongación de sonidos de consonantes y de vocales, fragmentación de palabras, bloqueo en el habla audible o silencioso, circunloquios (sustitución de palabras para evitar palabras problemáticas), y producción de palabras con exceso de tensión".
Aproximadamente el 5% de los niños entre 2 y 5 años pueden experimentar disfluencias en algún momento debido a una maduración neurológica más lenta en el procesamiento del habla y del lenguaje. De estos niños, el 80% se recuperará de manera espontánea, especialmente las niñas, mientras que el 20% continuará teniendo tartamudez persistente en diferentes grados de gravedad en la edad adulta, afectando al 1% de la población mundial. El inicio del trastorno de la fluidez del habla de inicio en la infancia suele ocurrir alrededor de los 2,5 años, coincidiendo con el período de mayor expansión lingüística en el desarrollo del niño.
Es esencial distinguir entre las disfluencias evolutivas, que son normales en el desarrollo del lenguaje, y las disfluencias típicas de la tartamudez infantil, que incluyen bloqueos, repeticiones y prolongaciones acompañadas de tensión, evitación y movimientos asociados en la cara y el cuello. Esto es crucial ya que el enfoque y el pronóstico para cada tipo de disfluencia serán diferentes (Tabla 3).

Tabla 3.

Disfluencias evolutivas vs Tartamudez infantil (Rupérez et al., 2022)

	Disfluencias evolutivas	Tartamudez infantil
Edad de aparición	2,5-5 años	2,5-5 // 6-7 años
Duración	Entre semanas-meses	Más de 12-14 meses
Evolución	Tienden a remitir y desaparecer	Son intermitentes
Disfluencias	Repiten frases, palabras polisílabas o sílabas con menos de 3 unidades de repetición	Repetición de sílabas (más de 3 unidades), palabras monosílabas, prolongaciones y bloqueos
Tensión	No hay tensión al hablar	Sí hay un esfuerzo evidente
Evitaciones	No hay evitaciones	Sí hay, a personas, situaciones...
Movimiento asociado	No hay movimientos asociados	Sí hay, en ojos, cara y cuello

Este trastorno, que tiene un origen neurobiológico con un fuerte componente genético, también se ve influenciado por factores psicosociales. Las personas que lo padecen pueden experimentar problemas internos como baja autoestima y ansiedad, los cuales tienden a cronificarse si no se tratan de manera temprana. Los niños que presentan tics asociados al tartamudeo, muletillas,

más de 3 repeticiones de sonidos o sílabas, o una velocidad de habla muy rápida, tienen una mayor probabilidad de desarrollar una tartamudez crónica.

Sección 2.6 Trastorno de la Comunicación no especificado

La categoría del trastorno de la comunicación no especificado se debe utilizar (según el DSM-5) en situaciones en las que el clínico opta por no especificar el motivo de incumplimiento de los criterios de trastorno de la comunicación o de un trastorno del desarrollo neurológico específico, e incluye presentaciones en las que no existe suficiente información para hacer un diagnóstico más específico.

En la CIE-11 se incluye como Trastorno del desarrollo del habla y del lenguaje sin especificación y se argumenta que esta categoría no debe utilizarse a menudo, sino hacerlo únicamente en los casos donde haya un deterioro significativo del desarrollo del habla o lenguaje

CLASIFICACIÓN DE LOS TRASTORNOS DEL HABLA

Sección 3.1 Introducción

Los trastornos del habla implican una dificultad para comunicarse para aquellas personas que lo padecen. Dentro de ellos pueden darse aquellos que afectan a la producción de los sonidos, o articulación, a la fluidez y a la voz y que, por tanto, inciden, en mayor o menor medida, en la inteligibilidad del habla.

Sección 3.2 Trastornos de los Sonidos de Habla

Los trastornos de los Sonidos del Habla, anteriormente denominado como dislalia, ya ha sido desarrollado en el anterior apartado de los Trastornos de la Comunicación, como parte de la clasificación del DSM-5 (APA, 2013). En este apartado se amplía un poco más este aspecto.

El desarrollo fonético-fonológico constituye un proceso progresivo que se extiende durante un periodo considerable de la infancia y en el que se producen cambios cualitativos y cuantitativos en la adquisición y organización de los sonidos del habla. En consecuencia, la valoración de las producciones infantiles debe realizarse atendiendo a los hitos evolutivos propios de cada etapa, evitando considerar como patológicas aquellas manifestaciones que forman parte del desarrollo típico. Sin embargo, a partir de determinadas edades, y especialmente desde los 3 años, es necesario conocer qué producciones fonéticas y fonológicas se consideran esperables y cuáles deberían encontrarse ya adquiridas. Este conocimiento permite identificar de forma temprana posibles desviaciones respecto al desarrollo normativo y facilita la detección, evaluación e intervención precoz de los trastornos de los sonidos del habla (Tabla 4)

Tabla 4.

Signos de alerta de procesos fonológicos ya inadecuados por edades

Edad	Signos de alerta de procesos fonológicos
3 años	• Inconsistencia en el uso de vocales. No lateralizar (ausencia de /l/) • Posteriorizar sonidos frontales (fonemas que se producen en la zona anterior como la /p/ se sustituyen por sonidos posteriores como la /k/) • Omitir sílabas (/eta/ por chaqueta) • Desnasalizar (una consonante nasal → m, n o ñ pierde ese rasgo nasal); por ejemplo, /tuve/ en vez de nube • Sonorizar fricativas o fricatizar sonidos (sonidos "cortos" se transforman en sonidos "largos"); por ejemplo /sato/ por gato
4 años	Aparte de los anteriores: • Frontalizar sonidos posteriores (fonemas que se producen en la zona posterior, como la /k/, se sustituyen por sonidos anteriores como la/t/); por ejemplo: /tasa/ en vez de casa • Oclusivizar: hacer cortos sonidos largos, como por ejemplo /pesa/ en vez de fresa) • Pérdida de africación (la ch se transforma en un sonido oclusivo, generalmente la /t/; por ejemplo, /tino/ en vez de chino • Lateralización (algunas consonantes como la /r/ se sustituyen por /l/; por ejemplo, /kala/ en vez de cara • Conversión de la /d/ en líquida (r o l); por ejemplo, /niro/ en vez de nido • Ausencia de /r/, pérdida de sonoridad: consonantes sonoras como la /b/ pasan a ser sordas; por ejemplo, /parco/ en vez de barco • Palatalización (hacer palatales consonantes que no lo son)

	• Sonorización de fricativas; por ejemplo, /beta/ en vez de seta • Posteriorización de vibrantes ("hacer la rr "en la garganta", como por ejemplo, /gana/ por rana • Omitir la consonante inicial de una sílaba, como por ejemplo, /ato/ en vez de pato) • Metátesis (cambio de orden de las sílabas; por ejemplo: /same/ por mesa • Coalescencia (dos sonidos diferenciados se convierten en otro distinto; por ejemplo: piela por piedra) y epéntesis (inserción de sonidos; por ejemplo, /kalase/ en vez de clase)
5 años	Aparte de los anteriores: • /q/(z) → /f/, /s/ (seseo*) • Avance de la /s/ (ceceo*) • Omisión de codas
6 años	Aparte de los anteriores: • Ausencia de /r/ (vibrante múltiple) • Posteriorización de vibrantes (rr "en la garganta") • Aspiración de /s/ ante oclusiva (por ejemplo: /mohka/ por mosca) • Reducción de grupos consonánticos (CCV → CV); por ejemplo: pato por plato, /ten/ por tren • Asimilaciones (usar un sonido de la palabra en varias posiciones dentro de la misma); por ejemplo, /kokolilo/ por cocodrilo

Nota. Tabla extraída de Rupérez et al. (2022)

De acuerdo con Susanibar et al. (2016), las manifestaciones de los trastornos de los sonidos del habla (TSH) pueden agruparse en tres categorías: alteraciones fonéticas, alteraciones fonológicas y alteraciones fonético-fonológicas.

Alteraciones fonéticas: se caracterizan por la dificultad para producir determinados sonidos de acuerdo con lo esperable para la edad cronológica del niño, tanto de forma aislada como en sílabas, palabras o frases. Los errores pueden consistir en omisiones, cuando el sonido no se produce; sustituciones, cuando se reemplaza por otro; o distorsiones, cuando el sonido se produce de forma incorrecta. Estas dificultades se relacionan principalmente con la ejecución y precisión de los movimientos necesarios para la producción del habla.

Alteraciones fonológicas: se relacionan con dificultades en la organización y utilización del sistema fonológico. El niño puede producir correctamente un sonido de forma aislada o en determinados contextos, pero emplearlo de manera inadecuada en palabras o en el habla espontánea. Estas dificultades pueden manifestarse mediante patrones de simplificación fonológica y, en algunos casos, asociarse a dificultades en la discriminación de los contrastes fonológicos.

Alteraciones fonético-fonológicas: se produce una combinación de dificultades fonéticas y fonológicas, de manera que coexisten problemas en la ejecución de determinados sonidos con dificultades en su organización y utilización dentro del sistema fonológico. Este perfil requiere valorar ambos componentes para establecer una intervención ajustada a las características específicas del niño.

Sección 3.3 Disglosia

3.3.1. Conceptualización y clasificación

Se conocen como disglosias a las alteraciones de la articulación de los fonemas causados por alteraciones de los órganos periféricos del habla y de origen no neurológico central. Estas pueden tener varias causas y se localizan en diferentes órganos del habla, únicas o asociadas. Pueden diferenciarse entre las malformaciones congénitas, las alteraciones del crecimiento, las parálisis periféricas, traumatismos y sus consecuencias (Coll-Florit et a., 2014). Según su división anatómica puede diferenciarse, principal entre: disglosias labiales, mandibulares, linguales y palatinas.

3.3.2. Disglosia labial

Se conoce como disglosia labial a la alteración de la articulación de los fonemas por alteración de la forma, fuerza o consistencia de los labios. Dentro de sus causas puede distinguirse el labio leporino, el frenillo labial superior hipertrófico, la macrostomía, la parálisis facial, la neuralgia del trigémino y las heridas (Molina, 2017).

En lo que respecta al labio leporino, tal y como señalan Coll-Florit et al. (2014), este tiene muchas variedades, desde la simple depresión del labio hasta la hendidura total. Se distingue entre labio leporino simple y el labio leporino total, el cual va asociado a la hendidura alveolar y, en general, a la fisura palatina. Además, a su vez, también puede distinguirse entre labio leporino unilateral, cuando afecta a un solo lado, y bilateral, cuando afecta a los dos lados.

En relación con el labio leporino medio o central, se produce a expensas de la falta de unión de los dos mamelones nasales internos y es una alteración poco frecuente. La malformación puede llegar a ser desde una simple escotadura media labial a extenderse por todo el tubérculo medio, creando una amplia hendidura que abarca las dos fosas nasales (véase Figura 1).

Caso diferente es el del frenillo labial superior hipertrófico, el cual es relativamente frecuente y es causa de una disglosia heterogénea. Este tipo de alteración impide la movilidad normal del labio superior y produce una separación de los incisivos centrales, apareciendo así una dificultad en la articulación de los fonemas /u/, /p/, /b/ y /m/. Las bilabiales son sustituidas por la labiodental /f/. La macrostomía, también denominada alargamiento de la hendidura bucal, por su parte, suele ir asociada a malformaciones del oído externo por afectación del primer arco branquial.

En antepenúltimo lugar se encuentra la parálisis facial, la cual es frecuente en niños y puede ocurrir en los primeros años de vida. Algunas veces surge de un trauma obstétrico debido al fórceps o por la comprensión contra los huesos pelvianos. En otras ocasiones se debe supuraciones del oído medio y de los mastoides. Asimismo, puede ser también debida a la poliomielitis aguda en la protuberancia y a la parálisis posdiftérica (Coll-Florit et al. 2014). Cada sujeto una dificultad diferente para hablar. En algunos se nota un sigmatismo con betacismo, y suele darse la queja de sensación de boca llena.

En cuestión de subtipologías, tal y como señalan Alexandra y Narváez (2020), la parálisis bilateral adquirida provoca una alteración en la pronunciación de los fonemas labiales considerable. La /p/ suena como /f/, la /m/ suena como /n/ y la /b/ tiene un sonido bilabial fricativo. Las vocales

también quedan afectadas porque las mejillas no tienen ninguna tensión, y al no existir el movimiento labial de protrusión, se articulan mal las vocales /o/ y /u/. En suma, se altera también el movimiento de separación de las comisuras para /e/ e /i/. Así pues, el habla queda muy afectada. La parálisis bilateral congénita, en cambio, produce una ligera disglosia, que se manifiesta sólo con métodos de exploración muy finos y exactos (Neira y Gómez, 2012).

En penúltimo lugar se encuentra la neuralgia del trigémino puede deberse a afecciones dentarias o sinusales, afecciones óseas de la base del cráneo; tumores, abscesos o aneurismas intracraneanos, meningitis, esclerosis en placas, etc. Las intoxicaciones o las afecciones crónicas pueden actuar como predisponentes. El síntoma característico es el dolor brusco, el cual va acompañado de enrojecimiento de la mitad de la cara, lagrimeo y sialorrea. Este dolor puede aparecer al masticar o al hablar (Coll-Florit et al. 2014).

Finalmente, tal y como mencionan Montero y Carnerero (2016), las heridas de los labios pueden ser ocasionadas por traumatismo y por herida de arma blanca o de fuego. Producen una palabra borrosa. Todavía peor es la disglosia por pérdida de labio a raíz de una herida de guerra o de resección por cáncer. En estos casos el sonido /p/ suena como /f/ borroso, y /m/ se sustituye por un sonido nasal impreciso. En la pérdida del labio superior, para articular los sonidos /b/, /p/ y /m/, el labio inferior contacta con los incisivos, como en /f/, o a veces incluso llega hasta detrás de ellos.

3.3.3. Disglosia mandibular

La disglosia mandibular es la alteración de la articulación de los fonemas por alteración de la forma de uno o ambos maxilares. Puede ser de causa congénita o del desarrollo, quirúrgica o traumática. Entre sus causas más frecuentes se encuentran la resección del maxilar superior e inferior, la atresia mandibular, la progenie y las alteraciones patológicas. Dado el objetivo del tema, se hará hincapié en las tres últimas causas (Coll-Florit et al. 2014).

En lo que respecta a la atresia mandibular, es una anomalía cogénita que consiste en un empequeñecimiento de la mandíbula debido a una detención del desarrollo del maxilar inferior por causas congénitas o por causas adquiridas (i.e., chuparse el dedo o el uso del chupete). La barbilla está hundida y existe una desproporción entre la lengua y la cavidad bucal (Martins et al. 2008).

Por su parte, la progenie se caracteriza por que la mandíbula inferior es muy prominente y, debido a ello, no es normal la relación entre los maxilares superiores e inferiores y se pierde la articulación entre los dientes (véase Figura 2). Impide una masticación normal por la maloclusión dentaria y predispone la caída de los dientes por piorrea alveolar (Pacora y Ruiz, 1995).

Por último, la maloclusión puede darse en sentido sagital, vertical y transversal, la primera se produce cuando los dientes están adelantados a partir de su implantación, la segunda cuando los incisivos inferior y superior no están colocados en un mismo plano vertical y, la tercera, se produce cuando está disminuida la anchura entre los molares superiores de ambos lados. Suele ocurrir en el paladar ojival (Medina, 2010).

3.3.4. Disglosia lingual y disglosia palatina

En primer lugar, en lo que respecta a la disglosia lingual, es la alteración de la articulación de fonemas a causa de una alteración orgánica de la lengua. Las causas que impiden la movilidad

de la lengua son, entre otras, la anquiloglosia, la parálisis, las pérdidas de sustancia en las quemaduras, la glosectomía y las malformaciones (Tabla 5).

Tabla 5.
Causas que impiden la movilidad de la lengua (Coll-Florit et al. 2014)

Causas	Desarrollo
Anquiloglosia	En la anquiloglosia, el volumen de la lengua es muy diferente en un niño u otro. La punta de la lengua es relativamente corta, el frenillo parece por ello llegar a la punta de la lengua. Sin embargo, el niño puede mover la lengua entre las encías y bien pronto puede sacarla fuera de la boca.
Parálisis unilateral	Aunque algunos autores afirman que la parálisis unilateral ocasiona pocas alteraciones, aparecen dislalias, sobre todo en los fonemas /d/, /t/, /l/, /s/ y /T/. También pueden producir un sigmatismo lateral funcional. El fonema /r/ desaparece en todos los casos y se sustituye por un lambdacismo lateral. Los sonidos linguales posteriores /g/ y /k/ pueden verse alterados. Las vocales que se resienten más de la parálisis del hipogloso son /e/, /i/ y /o/. Por ello, el habla, en general, aparece borrosa, débil y de difícil comprensión.
Parálisis bilateral	La parálisis bilateral de la lengua puede deberse a la siringobulbia, la esclerosis lateral amiotrófica, la parálisis bulbar, la parálisis seudobulbar y, menos frecuentemente, a la tabes por neuritis del hipogloso.
Fulguración lingual	Se suele producir alrededor del primer año de vida y suele deberse a la introducción de la punta de la lengua en un enchufe eléctrico. Debido a la humedad se produce una descarga eléctrica que quema la punta de la lengua.
Glosectomía	La pérdida de una gran parte de la lengua produce una alteración importante del habla. La /d/ suena como /g/; la /t/ como /k/; la /s/ como /s/ y la /r/ no se puede pronunciar. La /l/ es muy gangosa, parece una /i/, o falta del todo. Las vocales /e/ e /i/ son difíciles de emitir. A veces los movimientos linguales producen dolor. La pérdida total de la lengua produce una gran dificultad para la emisión del habla, pero no la mudez como creen muchas personas.
Malformaciones de la lengua	Las malformaciones congénitas de la lengua se deben a una alteración en el desarrollo embriológico. Los casos más graves se dan en recién nacidos no viables o muy malformados.
Macroglosia esencial	Consiste en una hipertrofia simple de la musculatura estriada de la lengua. Los más frecuentes son casos congénitos, siendo a veces familiares. La macroglosia esencial es muy probable en los niños con el síndrome de Down y en algunos oligofrénicos.

Glosoptosis	La caída de la lengua hacia atrás dentro de la faringe produce dificultades respiratorias importantes. Suele ir asociada a otras malformaciones bucales.

En relación con la disglosia palatina, es la alteración de la articulación de los fonemas provocada por alteraciones orgánicas del paladar óseo y del velo del paladar (Coll-Florit et al. 2014). Se encuentran diferentes formas: la fisura palatina, bastante frecuente; la fisura submucosa; el paladar corto, y otras anomalías menos frecuentes, como las parálisis funcionales y los traumatismos, yatrógenos o no, que afectan a la región del paladar.

Sección 3.4 Disartria

La disartria implica una alteración de la articulación de los fonemas, atribuyéndose a una lesión del sistema nervioso central y periférico que ocasiona alteración en el control en la fuerza, velocidad, rango, regularidad tono o en la precisión de los movimientos de los músculos de los órganos fonoarticulatorios. Comprendiendo, además, disfunciones motoras de la respiración, fonación, resonancia, articulación y aspectos prosódicos del habla (Pichot et al. 1995).

Dentro de esta alteración se descartan aquellas dificultades del desarrollo de la articulación, la tartamudez o aquellos basados en una alteración somática estructural psicológica. En aquellos casos en que la disartria sea muy severa, llegando a imposibilitar la articulación, se estará hablando de una anartria (Peña, 1995).

Las disartrias son una alteración que afecta a la motricidad causado por diferentes factores etiológicos: vasculares, traumáticos, infecciosos, neoplásicos o degenerativos que afectan al sistema nervioso central y periférico. Pudiendo ser de causa congénita o adquirida, y presentando diferentes grados de intensidad. Estos factores son los que determinarán su evolución junto a las características del sujeto y una posible recuperación, así como a influyen en la intervención logopédica que se pueda llevar a cabo (Melle, 2012).

Según Hernández (2007), la clasificación clínica que se lleva a cabo en este tipo de alteración hace referencia a la afectación del sistema nervioso que se produce y a las características que provocan en la persona, existiendo los siguientes tipos principales de disartrias (aunque también se trabajarán los secundarios): *flácida, espástica atáxica, hipocinética, hipercinética, mixta y apraxia del habla*, esta última es entendida como la forma más grave de disartria, por lo que algunos autores o profesionales no la incluyen como un tipo de disartria, sino como una alteración aparte de la comunicación

Sección 3.5 Trastornos de la fluidez

La tartamudez (o anteriormente disfemia) es una ruptura de la fluidez del habla, la cual ocurre sin ser planificada por el hablante y sucederá incluso cuando el sujeto sabe perfectamente lo que quiere decir, por ello es considerada una ruptura involuntaria y comprenderla es uno de los mayores desafíos en disciplinas tan dispares como la lingüística, la logopedia o fonoaudiología (Susanibar et al. 2016).

Es importante dejar claro desde el principio que la tartamudez o disfemia también es considerada una alteración del lenguaje. Tanto la fonoaudiología como la terapia del habla asumen al lenguaje como su objeto de estudio.

Para tener un buen lenguaje, y sea considerado adecuado, tenga claridad y cumpla su objetivo de comunicar, el individuo necesita de un cerebro en condiciones de aprender, tener integridad auditiva, motricidad orofacial, voz, articulación y coordinación pneumofónica adecuadas (Susanibar et al. 2016).

La fluidez, por su parte, tiene una importancia significativa para que la producción, que es la expresión oral del lenguaje, sea comprendida. Tener una buena fluidez es parte de los parámetros de un lenguaje eficaz, cuyo objetivo es la comunicación. Así, cuando hay rupturas en la fluidez, todo el sistema del lenguaje también se quiebra. La falta de sincronía resultante, si es excesiva y fuera de lo esperado para su comunidad lingüística, podrá ser considerada una alteración de la fluidez (Coll-Florit et al. 2014).

Por último, en cuestiones de delimitación conceptual, el DSM V considera la tartamudez como un Trastorno de la Comunicación en general y es descrito como Trastorno de la Fluidez que debe iniciarse en la infancia, en particular.

Sección 3.6 Disfonía

3.6.1. Concepto

Se considera que hay una alteración de la voz cuando su timbre, tono, intensidad o flexibilidad difieren de los de las voces de las demás personas del mismo género, edad y grupo cultural con desarrollo típico. En este sentido, la disfonía es un cambio en el tono de la voz, percibido por el sujeto y su entorno, que se produce por una mala vibración de una o ambas cuerdas vocales (Castillo et al. 2015). Dicha alteración indica una patología laríngea y no debe confundirse con otras alteraciones de la voz que se producen por una modulación inadecuada de esta en el área orofaríngea (i.e., rinolalia, faringolalia o déficit fonatorio derivado por enfermedades que afectan a la capacidad pulmonar).

3.6.2. La disfonía como signo

La disfonía, como alteración de la voz, puede interpretarse como un signo de enfermedad, como un síntoma de enfermedad o como un mero trastorno de la comunicación. Ante un sujeto cuya voz suene anormal, la principal preocupación será determinar si la disfonía significa la presencia de una enfermedad (Cobeta et al. 2013). En ese momento, las consideraciones estéticas o comunicativas son secundarias, al ser consciente de que una disfonía puede ser el signo cardinal de una alteración laríngea, primera manifestación de una enfermedad grave, local o sistémica.

Por tanto, hay que averiguar la causa o causas de la alteración de la voz, si es posible. Una voz con timbre aéreo que aparece de forma gradual y progresiva puede tener una importancia menor desde el punto de vista estético, social y comunicativo, pero puede ser el primer signo de aparición de una enfermedad neurológica importante (Núñez y Morato, 2013). Una vez

conocida y tratada la causa de la disfonía, se tomará en consideración su implicación en la comunicación, con el fin de llevar a cabo las medidas rehabilitadoras necesarias.

3.6.3. La disfonía como síntoma

Si se toma en consideración la disfonía como síntoma de enfermedad y que el propio concepto de "síntoma" hace referencia a la queja con que un sujeto expone una sensación subjetiva, real o imaginaria, se pueden distinguir tres situaciones (Cobeta et al. 2013). En primer lugar, que sea percibida como patología, con lo que se establece el acuerdo de la necesidad de estudiar y tratar el problema.

En segundo lugar, que el profesional esté convencido de la necesidad de investigar y tratar una alteración vocal, pero no el sujeto que padece la alteración. La situación se origina porque el primero sobrestime la presunta alteración vocal o por indiferencia del segundo ante un problema real (Sanabria et al. 2013). En ambos casos, el diagnóstico y el tratamiento discurrirán en una franca o tácita resistencia, desinterés o incluso hostilidad por parte del segundo.

Por último, que el sujeto esté convencido de que su voz está alterada, aunque el profesional crea que el problema es trivial o inexistente. Este conflicto se asocia en general a una reacción exagerada del primero, y con frecuencia es una secuela del proceso de recuperación de una enfermedad o intervención quirúrgica laríngea (Núñez y Morato, 2013). Tales reacciones son una expresión de hostilidad, de perfeccionismo o de una depresión que requiere asistencia psicológica.

3.6.4. La disfonía como alteración de la comunicación

Aunque la disfonía puede ser un indicador de salud o enfermedad, la voz también puede evaluarse como un instrumento de comunicación. Desde este punto de vista, hay que tener en cuenta una serie de consideraciones.

En primer lugar, debe preguntarse si la voz es o no adecuada para lograr la inteligibilidad del discurso, si sus características estéticas son aceptables y si satisface los requerimientos sociales y laborales del sujeto. Por tanto, se entiende que dicho instrumento tiene una importancia personal, social y económica. En este sentido, tal y como apuntan Cobeta et al. (2013), es bien sabido por todos que, conforme se asciende en la escala socioeconómica, aumenta la importancia de tener una voz efectiva y agradable. Con pocas excepciones, cuanta mayor dependencia social y profesional se tiene de la voz, más devastadores son los efectos de una disfonía.

Así, la voz puede servir solo para establecer una comunicación, pero también, en mayor o menor medida, para desarrollar una profesión. Cuanto más en relación esté la actividad profesional de un paciente con un perfecto estado de la voz, más profesional será el uso de esta. De cierta manera, siguiendo a Núñez y Morato (2013), todas las personas que desarrollan su actividad profesional relacionándose verbalmente con los demás tienen un uso profesional de la voz. En el mundo actual, donde la comunicación y la imagen personal tienen tanta importancia, la diferencia entre voz y uso profesionales de la voz es muy tenue.

3.6.5. Taxonomía de la disfonía

En la actualidad no existe una nomenclatura estándar para los trastornos de la voz ni para la patología de las cuerdas vocales. En el pasado, el término de *disfonía funcional* se identificaba

con idiopático e incluía numerosos casos de disfonía en los que, probablemente, debido a las limitaciones de los procedimientos de exploración, no podía reconocerse ninguna alteración de la forma ni del comportamiento laríngeo (Sanz et al. 2015). Además, tampoco estaba clara, tomando en consideración las diversas culturas y lenguas, la diferencia entre los términos *funcional* y *psicógeno*, lo cual generaba interpretaciones erróneas derivadas de la no individualización de ambas causas tan afines.

La definición de *disfonía funcional* considera que son funcionales todas las formas de alteración vocal en que la desviación del patrón normal de funcionamiento es el mayor factor causal y que, por ello, se encuentra ligada a la consideración de perturbación del gesto vocal. Sobre esta premisa conceptual se precisa que los trastornos de la voz, o disfonías, pueden dividirse en funcionales, orgánicas o espasmódicas (Saavedra-Mendoza y Akaki-Caballero, 2014).

3.6.5.1. Disfonía funcional

Se utiliza para hacer referencia a una alteración vocal derivada de una mala utilización de la voz que no se debe a una enfermedad orgánica identificable. Se define, por tanto, como una alteración por una descoordinación entre la respiración, la laringe y/o los resonadores. Entre sus subtipologías se encuentran la hipercinética y la hipocinética (Rojas, 2018).

La primera se debe a un exceso de tono muscular a nivel de la musculatura intrínseca de la laringe. Normalmente, se produce después de realizar abusos vocales intensos o de larga duración. Suele haber una tensión general que provoca incoordinación fonorespiratoria, alteración postural, mala utilización de los resonadores y molestias laringo-faríngeas (Cobeta et al. 2013). A su vez, se dividen en contracción isométrica (se debe a un efecto de cierre glótico posterior por el estado de hipertonía del músculo cricoaritenoideo posterior) contracción medial de bandas (las bandas ventriculares se aproximan a la línea media ejerciendo una hiperfonación), contracción anteroposterior (provoca una disminución del espacio laríngeo entre la epiglotis y los aritenoides) y contracción esfinteriana (se produce un aumento de tensión y contracción anteroposterior extrema o circular).

La segunda, por su parte, tal y como apuntan Sanz et al. (2015), es debida a un defecto del tono muscular a nivel de la musculatura intrínseca de la laringe, es decir, hay una falta de fuerza de las cuerdas vocales. Normalmente, se produce después de largos períodos de silencio. El inicio en fonación es difícil, pero va mejorando a medida que se va hablando. Incluye defectos de cierre glótico (se presenta fatiga vocal, aclaración, voz aérea y fonastenia), presbifonías (deterioro fisiológico de la voz de los ancianos que depende de la concurrencia de muchos sistemas y aparatos.

En este sentido, cabe mencionar que, siguiendo a Núñez y Morato (2013), los sujetos presentan una reducción de la extensión vocal, temblor, voz aérea y tensa) y atrofias de cuerdas (adelgazamiento de la musculatura tiroaritenoidea de las cuerdas vocales que se puede deber al uso de glucorticoides inhalatorios, enfermedades neurológicas o al envejecimiento progresivo que acabará produciendo un defecto de cierre glótico y, por tanto, voz aérea).

3.6.5.2. Disfonía orgánica

Se deriva de lesiones, ya sean congénitas (quiste epidermoide, *culcus gottidis*, puente mucoso o surcofisura de cuerda vocal) o adquiridas (lesiones paranodulares, edema de Reinke, quiste por

retención mucosa, hemorragia submucosa de la cuerda vocal, latigazo laríngeo, úlcera de contacto, granulomas postincubación, parálisis recurrencial unilateral, neoplasia incipiente de cuerda vocal, bronquitis crónica, asma, vegetaciones, etc.), en alguno o algunos de los órganos directa o indirectamente encargados de la fonación (Rojas, 2018).

Debido a su alta incidencia, caben resaltar las laringitis, tanto aguda (inflamación de la laringe producida como consecuencia de una infección vírica) como crónica (inflamación debida a la confluencia de diversos factores genéticos constitucionales y otros externos contraproducentes para la producción de sonidos, como el exceso de frío, humos y polvo inhalados). Ambas alteraciones se manifiestan de forma especial en la población infantil, tanto desde el punto de vista cuantitativo (elevada frecuencia de aparición entre los 5 o 6 años y la pubertad) como cualitativo (repercusión trascendental). De ahí que sea recomendable la prevención de ellas en el periodo cronológico reseñado (Guzmán et al. 2012).

Otras patologías asociadas a las disfonías, como se verá más adelante, son la bronquitis crónica, el asma y las vegetaciones.

3.6.5.3. Disfonía psicógena

Dentro de la tipología de disfonía psicógena pueden diferenciarse dos subtipologías asociadas, por un lado, la disfonía de conversión, la cual consiste en la pérdida total o parcial de la capacidad fonatoria debido a factores psicógenos. Se presenta en sujetos con alteraciones emocionales que somatizan sus problemas de tipo familiar, laboral, económico o afectivo a nivel laríngeo (Sanz et al. 2015). Este subtipo es de aparición brusca y se observa con más frecuencia en mujeres jóvenes, las cuales presentan una disfonía de aparición brusca, un comportamiento vocal de esfuerzo y tensión corporal.

Por otro lado, se encuentra la disfonía de movimiento vocal paradójico, una alteración involuntaria donde existe un movimiento inverso de las cuerdas vocales que consiste en que en la inspiración se aproximan las hemilaringes y en la espiración se separan (Rojas, 2018). Consiste en una hiperaducción laríngea sobre todo en la inspiración, pero también en la espiración, que da como resultado obstrucción y disnea, en la que cuanto más trata el sujeto de inspirar, más intensa es la aducción. Entre las crisis, la laringe es completamente normal y no presentan disnea (Cobeta et al. 2013).

3.6.5.4. Disfonía espasmódica

Es una distonía focal laríngea en la que hay un desorden de la voz debido a una interrupción o disrupción del control motor laríngeo, el cual origina movimientos involuntarios de la musculatura laríngea durante la fonación (Sanz et al. 2015). Estos movimientos involuntarios pueden dar lugar a dos tipos distintos de disfonía, a un excesivo cierre glótico por aproximación (aducción) o a un cierre incompleto y una aproximación irregular de las cuerdas vocales por separación (abducción).

RESUMEN DEL TEMA

Los trastornos de la comunicación y el habla constituyen un conjunto heterogéneo de alteraciones que pueden afectar a la comprensión, producción y utilización del lenguaje, así como a la articulación, fluidez y voz. Su aparición durante las primeras etapas del desarrollo puede repercutir significativamente en el funcionamiento social, académico y personal. El abordaje de estas alteraciones requiere, por tanto, conocer las características específicas de cada trastorno y establecer un adecuado diagnóstico diferencial, teniendo en cuenta aspectos como la edad, el desarrollo evolutivo, la etiología y la posible coexistencia con otros trastornos del neurodesarrollo.

Trastornos de la comunicación. El DSM-5 incluye dentro de esta categoría el trastorno del lenguaje (TL), el trastorno de los sonidos del habla (TSH), el trastorno de la fluidez de inicio en la infancia (TFI), el trastorno de la comunicación social o pragmático (TCS) y el trastorno de la comunicación no especificado. El trastorno del lenguaje se caracteriza por dificultades persistentes en la adquisición y utilización del lenguaje, que pueden afectar a la comprensión y producción de palabras, frases, estructuras gramaticales y narraciones, tanto en la modalidad oral como escrita o signada. El trastorno de los sonidos del habla implica dificultades persistentes en la producción fonológica que afectan a la inteligibilidad o a la comunicación verbal; para su identificación es necesario diferenciar los errores propios del desarrollo de aquellos que se mantienen más allá de la edad esperable. El trastorno de la comunicación social o pragmático se manifiesta mediante dificultades para utilizar la comunicación verbal y no verbal de forma adecuada al contexto, comprender las intenciones de los interlocutores, seguir las reglas conversacionales e interpretar significados implícitos, como bromas o metáforas. Por su parte, el trastorno de la fluidez de inicio en la infancia se caracteriza por alteraciones persistentes en la fluidez y organización temporal del habla, como repeticiones, prolongaciones, bloqueos, fragmentaciones, circunloquios y tensión, siendo fundamental diferenciarlo de las disfluencias evolutivas. Finalmente, el trastorno de la comunicación no especificado se reserva para aquellas situaciones en las que existen dificultades significativas de la comunicación, pero no se dispone de información suficiente para establecer un diagnóstico más específico.

Trastornos del habla. Los trastornos del habla afectan principalmente a la producción de los sonidos, la articulación, la fluidez o la voz, pudiendo repercutir en la inteligibilidad de la comunicación. Los trastornos de los sonidos del habla deben valorarse atendiendo al desarrollo fonético-fonológico esperado para cada edad y pueden presentar alteraciones fonéticas, fonológicas o una combinación de ambas. Las disglosias son alteraciones de la articulación producidas por modificaciones estructurales de los órganos periféricos del habla y pueden ser labiales, mandibulares, linguales o palatinas. La disartria, por su parte, es una alteración motora del habla asociada a lesiones o disfunciones del sistema nervioso central o periférico, que pueden afectar a la fuerza, precisión, velocidad, tono y coordinación de los movimientos implicados en la respiración, fonación, resonancia, articulación y prosodia; en los casos más graves puede producirse anartria. Finalmente, los trastornos de la fluidez incluyen alteraciones como la tartamudez, caracterizada por interrupciones involuntarias del flujo normal del habla, mientras que las disfonías implican modificaciones de características vocales como el tono, timbre, intensidad o flexibilidad. Estas últimas pueden clasificarse en funcionales, orgánicas, psicógenas y espasmódicas, atendiendo a su origen y características.

GLOSARIO

Trastorno de la comunicación (TC): conjunto de alteraciones que afectan a la comunicación y que, cuando aparecen durante las primeras etapas del desarrollo, se consideran trastornos del neurodesarrollo. Pueden afectar al lenguaje, los sonidos del habla, la fluidez o el uso social de la comunicación.

Trastorno del lenguaje (TL): alteración caracterizada por dificultades persistentes en la adquisición y utilización del lenguaje, que pueden afectar a la comprensión y producción de palabras, frases, estructuras gramaticales y narraciones.

Trastorno del desarrollo del lenguaje (TDL): denominación actualmente recomendada para referirse a los cuadros que anteriormente se denominaban trastorno específico del lenguaje (TEL), evitando el término «específico» debido a que las dificultades pueden afectar a otros dominios además del lenguaje.

Trastorno de los sonidos del habla (TSH): dificultad persistente en la producción de los sonidos del habla que puede interferir en la inteligibilidad y en la comunicación verbal de mensajes.

Trastorno de la comunicación social o pragmático (TCS): alteración caracterizada por dificultades persistentes en el uso social de la comunicación verbal y no verbal, incluyendo la adaptación del lenguaje al contexto y la comprensión de las intenciones de los interlocutores.

Pragmática: dimensión de la comunicación relacionada con el uso del lenguaje en función del contexto social, las características del interlocutor y las convenciones que regulan la interacción comunicativa.

Trastorno de la fluidez de inicio en la infancia (TFI): alteración de la fluidez y de la organización temporal del habla que resulta inadecuada para la edad y las habilidades lingüísticas del individuo. Puede incluir repeticiones, prolongaciones, bloqueos, fragmentaciones y circunloquios.

Disfluencia evolutiva: interrupción de la fluidez que puede aparecer durante el desarrollo normal del lenguaje, especialmente entre los 2 y los 5 años, y que debe diferenciarse de las manifestaciones propias de la tartamudez infantil.

Trastorno de la comunicación no especificado: categoría utilizada cuando existen dificultades significativas de la comunicación, pero no se dispone de información suficiente para establecer un diagnóstico más específico.

Alteración fonética: dificultad para producir determinados sonidos del habla de acuerdo con lo esperado para la edad, pudiendo manifestarse mediante omisiones, sustituciones o distorsiones.

Alteración fonológica: dificultad relacionada con la organización y utilización del sistema fonológico. El niño puede producir correctamente un sonido de manera aislada, pero utilizarlo de forma inadecuada dentro de las palabras o durante el habla espontánea.

Alteración fonético-fonológica: perfil en el que coexisten dificultades tanto en la ejecución de determinados sonidos como en su organización y utilización dentro del sistema fonológico.

Disglosia: alteración de la articulación de los fonemas causada por modificaciones de los órganos periféricos del habla y que no tiene un origen neurológico central. Puede clasificarse en labial, mandibular, lingual y palatina.

Disglosia labial: alteración de la articulación asociada a modificaciones en la forma, fuerza o consistencia de los labios. Entre sus causas se encuentran el labio leporino, el frenillo labial superior hipertrófico, la macrostomía o la parálisis facial.

Disglosia lingual: alteración de la articulación de los fonemas producida por una alteración orgánica de la lengua que afecta a su movilidad, como puede ocurrir en la anquiloglosia, la parálisis o determinadas malformaciones.

Disglosia palatina: alteración de la articulación provocada por modificaciones orgánicas del paladar óseo o del velo del paladar, como la fisura palatina, la fisura submucosa o el paladar corto.

Disartria: alteración motora del habla asociada a una lesión del sistema nervioso central o periférico que afecta al control de la fuerza, velocidad, tono, precisión, rango o coordinación de los movimientos necesarios para la producción del habla.

Anartria: forma grave de alteración motora del habla en la que la afectación de la articulación llega a impedir la producción articulada del habla.

Disfonía: alteración de la voz caracterizada por modificaciones del timbre, tono, intensidad o flexibilidad respecto a las características esperables para personas del mismo género, edad y grupo cultural.

Disfonía funcional: alteración vocal derivada de una utilización inadecuada de la voz, sin que exista necesariamente una enfermedad orgánica identificable. Se relaciona con una descoordinación entre la respiración, la laringe y/o los resonadores y puede presentar formas hipercinéticas o hipocinéticas.

BIBLIOGRAFÍA

Alexandra, X., y Narváez, L. (2020). *Diversos tipos de disglosias y su asociación con la producción de fonemas* (Tesis Doctoral. Universidad Nacional de Chimborazo).

American Psychiatric Association., Kupfer, D. J., Regier, D. A., Arango López, C., Ayuso-Mateos, J. L., Vieta Pascual, E., y Bagney Lifante, A. (2013). *DSM-5: Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales (5ª ed.)*. Madrid: Editorial Médica Panamericana.

Artigas-Pallarès, J., Pérez, I. P., y Mallofré, E. V. (2022). Trastornos del lenguaje. *Pediatría Integral*, *7*, 12.

Camarero, E. (2009). Consecuencias y tratamiento de la disfagia. *Nutrición. Hospitalaria. Suplementos*, *2*, 66-78.

Castillo, A., Casanova, C., Valenzuela, D., y Castañón, S. (2015). Prevalencia de disfonía en profesores de colegios de la comuna de Santiago y factores de riesgo asociados. *Ciencia y trabajo, 17*(52), 15-21.

Cepeda, A. (2019). Trastornos de la comunicación y lenguaje II: Intervención. EOPEP´S: Junta de Castilla y León. Disponible en: https://www.educa.jcyl.es/crol/es/recursos-educativos/trastornos-comunicacion-lenguaje-ii-intervencion

Cobeta, I., Núñez, F., y Fernández, S. (2013). *Patología de la voz*. Marge books.

Cobeta, I., Núñez, F., y Fernández, S. (2013). Voz normal y clasificación de las disfonías. *Revista de la Sociedad Española de Otorrinolaringología y Patología Cérvico-Facial, 8*, 237-241.

Coll-Florit, M., Vila-Rovira, J. M., Aguado, G., Fernández-Zúñiga, A., Gambra, S., y Perelló, E. (2014). *Trastornos del habla y de la voz*. Barcelona: UOC.

González, J.J., y García, J.M. (2019). Trastornos del lenguaje y la comunicación. *Congreso de Actualización Pediatría*, *3*, 569-577.

González, R., y Bevilacqua, J. (2009). Disfagia en el sujeto neurológico. *Rev Hosp Clín Univ Chile, 20*, 252-262.

Guzmán, M., Callejas, C., Castro, C., García-Campo, P., Lavanderos, D., Valladares, M. J., y Carmona, C. (2012). Efecto terapéutico de los ejercicios con tracto vocal semiocluido en pacientes con disfonía músculo tensional tipo I. *Revista de logopedia, foniatría y audiología, 32*(3), 139-146.

Hernández, N. M. (2007). Intervención logopédica en la disartria. *Revista de logopedia, foniatría y audiología, 27*(4), 187-197.

Martins, L. G., Gandini, L. G., Schiavon, M. R. E. A., De Oliveira, C. A., y Palomino, S. P. (2008). Utilización de distracción osteogénica de la Sínfisis mandibular para tratamiento de atresia mandibular. *Revista CES Odontología, 21*(2), 49-55.

Medina, C. (2010). Prevalencia de maloclusiones dentales en un grupo de sujetos pediátricos. *Acta odontológica venezolana, 48(1), 94-99.*

Melle, N. (2007). *Guía de intervención logopédica en la disartria.* Madrid: Síntesis.

Melle, N. (2012). Disartria. Práctica basada en la evidencia y guías de práctica clínica. *Revista de logopedia, foniatría y audiología, 32*(3), 120-133.

Molina, F. P. (2017). Disglosia labial y palatal en Educación Primaria. *Revista Internacional de apoyo a la inclusión, logopedia, sociedad y multiculturalidad, 3*(1), 94-107.

Monfort, I., y Monfort, M. (2012). Utilidad clínica de las clasificaciones de las alteraciones del desarrollo del lenguaje. *Revista de Neurología, 54* (2),147-154.

Montero, A. A., y Carnerero, C. S. (2016). Actualización en el manejo de la neuralgia del trigémino. *SEMERGEN-Medicina de Familia, 42*(4), 244-253.

Neira, A. L., y Gómez, M. E. (2012). La disglosia y su influencia en la comunicación verbal de los niños (Tesis Doctoral. Universidad de Guayaquil).

Núñez, F y Morato, M . (2013). Disfonía Infantil. *Revista de la Sociedad Española de Otorrinolaringología y Patología Cérvico-Facial, 8*, 295-304.

Ortiz, K. (2014). *Tratado de evaluación de motricidad orofacial y áreas afines*. Madrid: EOS.

Ozanne, A. E., Murdoch, B. E., Attard, M. D., y Stokes, P. D. (1995). Impaired tongue strength and endurance in developmental verbal dyspraxia: a physiological analysis. *European Journal of Disorders of Communication, 30*(1), 51-64.

Pacora, P., y Ruiz, S. (1995). Nutrición materna: ¿Comer por dos para el bienestar del embarazo y la progenie? *Revista Peruana de Ginecología y Obstetricia, 41*(2), 8-17.

Peña, J. (1995). *Rehabilitación de las afasias y trastornos asociados*. Barcelona: Masson.

Pichot, P., López-Ibor, J., y Valdés, M. (1995). *Manual diagnóstico y estadístico de las alteraciones mentales*. Barcelona: Masson.

Rivera, B. R., y Carchi, P. A. (2021). *Programa de intervención logopédica para corregir y/o compensar el retraso de lenguaje de un alumno con discapacidad intelectual* (Tesis Doctoral. Universidad Nacional de Educación del Ecuador).

Rojas, J. A. (2018). Disfonía ocupacional en docentes. Revisión de la literatura. *Acta de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello, 46*(1), 62-70.

Rupérez, A., Ramos, I., Machado, I., Fernández, D., Gortazar, M., y Aguilera, S. (2022). Trastornos del lenguaje, del habla y de la comunicación. Conceptos, clasificación y clínica. *Protoc dign ter pediatr*, *1*(1), 19-30.

Sanabria, J., García-Ruiz, P., y Ahumada, F. (2013). Disfonías de origen neurológico. *Revista de la Sociedad Española de Otorrinolaringología y Patología Cérvico-Facial, 8*, 283-294.

Sanz, L., Rodríguez, M., Bau, P., y Rivera, T. (2015). Disfonía. *Medicine-Programa de Formación Médica Continuada Acreditado, 11*(91), 5433-5444.

Soto, M ª P. (2009). Evaluación del lenguaje en un alumno con disglosia. *Revista de Innovación y Experiencias Educativas, 15*, 1-16.

Susanibar, F., Dioses, A., Marchesan, I., Guzmán, M., Leal, G., Guitar, B., y Junqueira, A. (2016). *Trastornos del habla: de los fundamentos a la evaluación*. Madrid: Giunti EOS.

Valera, J. A. A. (2017). Trastornos de la comunicación desde el DSM-V La necesidad de diagnósticos diferenciales. *Cuadernos de neuropsicología*, *11*(1), 144-156

Velasco, M., y García-Peris, P. (2009). Causas y diagnóstico de la disfagia. *Nutrición Hospitalaria, 2*(2), 56-65.

Ygual-Fernández, A., y Cervera-Mérida, J. F. (2005). Dispraxia verbal: características clínicas y tratamiento logopédico. *Revista de Neurología, 40*(1), 121-126.